

Primers auxilis



Índex

- 1.- Principis d'actuació davant d'emergències.
- 2.- Triatge.
- 3.- La farmaciola a l'empresa.
- 4.- Primers auxilis:
 - Cremades.
 - Hemorràgies.
 - Traumatismes: fractures, luxacions i esquinços.
 - Cossos estranys.
 - Suport vital bàsic.
 - Altres situacions (problemes cardiovasculars, problemes respiratoris, ennuegament, convulsions, lipotímia, trastorns mediambientals i intoxicacions).
- 5.- Trasllats.



Principis d'actuació en els primers auxilis

Són les **primeres ajudes** que s'adopten inicialment amb un accidentat o malalt sobtat, en el mateix lloc dels fets, fins que es pugui obtenir una assistència especialitzada.

Principis d'actuació en els primers auxilis

Principis d'actuació bàsics: protegir (ferit i nosaltres), avisar, socórrer (PAS)

Principis d'actuació generals: actuar amb rapidesa, fer una composició del lloc i examinar les persones accidentades amb la finalitat d'actuar ràpidament.

Moure el ferit amb gran precaució: en posició horitzontal, si està conscient, i en posició lateral de seguretat (PLS), si està inconscient (si es té l'absoluta seguretat que no té lesions a la columna vertebral).

Mantenir el ferit calent

No donar mai beure a una persona inconscient

Tranquil·litzar la víctima

No deixar mai sol l'accidentat: l'estat del ferit es pot agreujar en un breu espai de temps.

Objectius dels primers auxilis:

- Preservar la vida
- Pal·liar el dolor
- Evitar lesions secundàries



Principis d'actuació bàsics: PAS

MÈTODE PAS

PROTEGIR

Cal vetllar per la **seguretat** de l'accidentat i del socorrista. Per això:

- Cal senyalitzar el lloc de l'accident.
- Cal eliminar possibles amenaces.
- Només si hi ha risc per l'accidentat, cal desplaçar-lo.

AVISAR

Cal **contactar** amb els serveis d'emergència i **informar-los** clarament de:

- Nombre i estat aparent dels ferits.
- Presència o no d'altres perills.
- Lloc exacte del succés.

SOCÓRRER

Cal **atendre** el ferit i valorar-ne les constants vitals.

[Principis](#) - Creu Roja
[Pauta General](#) - Creu Roja
[Pauta General](#) - SEM



Triage

És el procés **d'avaluació i classificació** de les **víctimes**, en cas d'accidents amb múltiples afectats, que permet prioritzar l'ordre d'atenció o evacuació. **Criteris:**

- **gravetat** del pacient
- **supervivència** amb els mitjans disponibles en el moment
- màxim període de **temps** que es pot diferir el tractament

Targetes de triatge	
Vermella (extrema urgència)	Ferits amb possibilitat de sobreviure, que necessiten assistència mèdica i evacuació prioritària amb control mèdic (no respira, inconscients, fortes hemorràgies...).
Groga (urgent)	Ferits greus que necessiten assistència hospitalària però que poden esperar per realitzar l'evacuació encara que necessitin cures mínimes prèvies.
Verda (no urgent)	Ferits lleus que no requereixen assistència hospitalària o mèdica immediata, que no tenen compromesa cap funció vital i que poden ser traslladats en vehicles no sanitaris.
Gris/negra (no requereix atenció)	Les víctimes mortals i els accidentats amb poques possibilitats de sobreviure.

S'hauran de **lligar al braç o a la cama**, mai a la roba o calçat.

[Triage](#) - SEM



La farmaciola a l'empresa

En **TOTS** els centres de treball, és **OBLIGATORI** comptar amb una **farmaciola de primers auxilis** adequada i degudament senyalitzada, ja que s'hi troben els elements indispensables per atendre les víctimes d'un accident o malaltia sobtada (material de curació, instrumental i elements addicionals).

Els centres de treball de **més de 50 treballadors** i els que realitzin activitats perilloses o presentin dificultats per accedir a centre d'assistència proper hauran de tenir:

- **local** destinat als primers auxilis
- **llitera**
- **font** d'aigua potable

El material **haurà d'estar**:

- ordenat
- etiquetat
- llistat de telèfons d'emergència
- sense pany
- revisat amb regularitat (reposat i no caducat)



FARMACIOLA



Les tècniques de primers auxilis en els accidents més comuns

La pràctica dels primers auxilis suposa una avaluació global del pacient, realitzada en **quatre fases**:

1. Valoració primària del pacient
2. Comprovació i manteniment de les constants vitals
3. Valoració secundària
4. Tractament definitiu

Cremades

Són lesions de la pell causades per contacte amb diversos agents.

Primers auxilis:

Allunyar la víctima de la font de calor

Refredar l'àrea cremada (sense gel)

No aplicar cap tipus de pomada

Cobrir amb gases netes

No treure la roba (excepte en cremades causades per substàncies químiques)

Retirar amb cura anells, polseres, rellotge o peces de roba ajustades i cinturons

No administrar líquids per via oral

Traslladar la víctima a un centre assistencial

[Cremades](#) - Creu Roja



Hemorràgies

Una **hemorràgia** és la sortida de sang dels vasos sanguinis com a conseqüència de la seva ruptura.

Primers auxilis en cas d'hemorràgies:

Hemorràgia capil·lar: la sang surt en forma de llençol i cobreix la superfície afectada. Es netejarà amb una solució antisèptica i es recobrirà amb una gasa estèril.

Hemorràgia venosa: la sang és de color grana i surt de forma continuada i sense força. Cal destapar la ferida i comprimir-la amb una compresa, mantenint elevat el membre ferit.

Hemorràgia arterial: la sang és de color vermell i surt a batzegades seguint el ritme dels batecs del cor. Amb el membre afectat una mica elevat, es deixa la ferida al descobert i es comprimeix.

Si la persona es **mareja** estira-la al terra i aixeca-li les cames. És important que **no netegis** la ferida fins que hagi deixat de sagnar, doncs podries desfer el quall. Neteja-la amb aigua i sabó i **no bufis**. No retiris **objectes clavats** perquè podrien estar contenint l'hemorràgia.

Si la ferida amb hemorràgia arterial es troba en una extremitat, s'hi podrà practicar un **torniquet**, però està reservat a **CASOS EXTREMS** i com a **ÚLTIMA MESURA**, ja que pot provocar greus conseqüències com la gangrena. No es podrà **TREURE (ni afluixar) MAI** fora de l'hospital encara que hagi cessat l'hemorràgia i caldrà anotar l'hora de l'aplicació.



Primers auxilis en cas d'hemorràgies internes:

Són les que es produeixen a l'interior de l'organisme, sense vessament extern.

Síntomes: Podem sospitar de l'existència d'una hemorràgia interna quan s'ha produït un traumatisme violent i la persona accidentada presenta símptomes com fred, pols feble, pal·lidesa o respiració ràpida. La manifestació més habitual és el xoc.

L'actuació en aquest cas serà:

- Controlar signes vitals.
- Evitar la pèrdua de l'escalfor corporal.
- Col·locar la víctima estirada, amb el cap més baix que els peus (si les lesions ho permeten) fins que arribi l'ambulància.
- Afluixar tot allò que pugui comprimir la víctima per facilitar la circulació.



Per casos de víctimes en situació de xoc.

Víctima estirada boca amunt (o lateralment) amb les cames més aixecades que el cap.



Primers auxilis en cas d'hemorràgies exterioritzades:

Són les que es produeixen a l'interior de l'organisme, però que surten a l'exterior a través d'un orifici natural del cos.

Hemorràgia nasal o epistaxi: cal col·locar la persona asseguda i amb el cap endavant, comprimint amb els dits les fosses nasals durant uns 5 minuts. No s'ha de taponar.

Hemorràgia per l'oïda o otorràgia: no s'ha d'actuar. Cal ajaure la persona del costat que es produeix l'hemorràgia i traslladar-la el més ràpidament possible a un hospital. No s'ha d'aturar ni taponar mai.

Hemorràgia per la boca: pot tenir l'origen al pulmó si ve precedida de tos, la sang és neta amb olor d'òxid i pot presentar aspecte escumós; o a l'estómac si ve precedida de basques, la sang presenta restes d'aliment i és pudenta i la víctima pot presentar inconsciència.

L'actuació serà diferent per cada cas: si és pulmonar col·locarem la víctima en posició semiasseguda i si és estomacal col·locarem la víctima en PLS.

Hemorràgia per l'anús: si és d'origen digestiu la femta és de color negre (melena) i si és d'origen rectal la femta es presenta amb sang vermella (rectorràgia). Cal traslladar la víctima al centre mèdic.



Per casos de problemes respiratoris.
Víctima semiasseguda amb el tronc a 45° o 50°.



Per persones inconscients.
Posició Lateral de Seguretat (PLS).
* Caldrà comprovar que la persona no té lesions cerebrals ni de columna.



Primers auxilis en cas d'hemorràgies exterioritzades:

Hemorràgia al orinar: cal traslladar la víctima al centre mèdic.

Hemorràgia vaginal: Cal traslladar la víctima al centre mèdic. Si hi ha embaràs, l'aparició d'una hemorràgia indica la necessitat d'una assistència sanitària urgent.

Actuació: col·locarem la víctima estirada en decúbit lateral esquerre i podem posar-li un apòsit sense introduir res. Quan calgui farem els canvis d'apòsit, però els guardarem perquè el centre sanitari pugui fer una valoració de la sagnia. També guardarem qualsevol tipus de teixit que surti de la vagina.



Traumatismes: fractures, luxacions i esquinços

Un **traumatisme** és una lesió sobre el cos causada per un impacte violent (fractures, esquinços o luxacions).

Una **fractura** és la ruptura total o parcial d'un os. Pot ser **oberta** (si produeix ferida a la pell i l'os trencat surt del cos) o **tancada**.

Primers auxilis:

Es procedirà a la **immobilització** del membre fracturat en el lloc en què es trobi el lesionat i abans de traslladar-lo. La immobilització es durà a terme amb suports rígids o fèrules. Cal recordar que el millor és la mínima intervenció. Si poden no mobilitzarem ni el membre ni la persona lesionada.

S'ha d'immobilitzar el membre fracturat per damunt i per sota d'aquest:

- D'espatlla: s'ha de subjectar amb cabestrell el braç contra el tòrax.
- De braç: s'ha d'immobilitzar amb cabestrell l'espatlla i el colze.
- De mà: s'ha de col·locar sobre un llistó, i s'ha de posar l'avantbraç en cabestrell.
- De cama i genoll: s'han de bloquejar amb fèrules i lligades.
- De vètebres: no s'ha de moure, ni incorporar ni asseure. L'han de traslladar els especialistes.
- De crani: cal posar-lo en PLS si està inconscient, abrigar-lo i vigilar-lo.

Si la fractura afecta la **columna vertebral**, prioritzarem la no intervenció. S'han d'extremar les cures ja que la mobilització pot provar lesions molt greus. Mantenir l'accidentat panxa enlaire, conservant l'alineació, com si fos un bloc rígid: cap, tronc i extremitats.



Traumatismes: fractures, luxacions i esquinços

Una **luxació** és el desplaçament dels ossos que formen una articulació.

Es poden acompanyar de la ruptura de lligaments o fibres musculars, produint dolor intens i inflor.

Primers auxilis:

Cal traslladar l'afectat a un centre mèdic.

No hem de reduir la luxació.

Un **esquinç** és la distensió o esquinçament dels lligaments que uneixen les articulacions.

Produeixen dolor intens, enrogiment i inflor, així com deformitat aparent de l'articulació i incapacitat per moure's.

Primers auxilis:

Cal mantenir l'extremitat lesionada enlaire i evitar moure-la.



Cossos estranys: ull, nas i orella

Un **cos estrany** és qualsevol partícula sòlida, líquida o gasosa que entra a l'ull de forma accidental. També s'hi consideren els objectes petits introduïts al nas o orella com: boletes, joguines, insectes...

Primers auxilis en cas de cos estrany a l'ull:

Què no hem de fer...	Com hem d'actuar...
No hem de fregar l'ull.	Intentarem obrir l'ull i localitzar el cos estrany.
No aplicarem líquids o gotes que no siguin sèrum fisiològic o aigua.	Rentarem l'ull amb abundant aigua o sèrum fisiològic a raig fluix (del lacrimal cap a fora). Cal mantenir les parpelles obertes durant el rentat. Si les molèsties continuen, cal girar la parpella al revés i netejar-la amb aigua per dintre. Si es tracta d'una cremada per líquids corrosius l'hem de rentar durant més de 20 min amb aigua corrent.
No intentarem treure el cos estrany amb cotó fluix.	Si persisteix i localitzem el cos estrany, podem intentar extraure'l amb cura amb una gassa.
No utilitzarem objectes punxants per treure cossos clavats.	Si està clavat, hem d'evitar manipular-lo. Traslladarem la víctima a un centre de salut.
No el taparem amb pressió.	Taparem l'ull amb gases netes i humides. Si les molèsties són importants taparem els dos ulls per prevenir lesions més greus.



Primers auxilis en cas de cos estrany a nas o orella:

Què no hem de fer...	Com hem d'actuar...
Evitem manipular l'interior del nas o l'orella amb objectes punxants.	Si presenciem la introducció de l'objecte, només hem d'intentar extreure'l si és visible.
No ficarem aigua per fer l'extracció del cos estrany perquè pot augmentar-ne el volum o introduir-lo més.	Si l'objecte està al nas podem tancar la fossa nasal lliure i fer mocar fort a la víctima.
Si l'objecte és esfèric, mai hem de fer servir pinces.	Si no el podem extreure cal traslladar la víctima a un centre de salut. Habitualment no es tracta d'una emergència.



Protocol d'actuació

La primera mesura d'actuació en l'atenció a un accidentat inconscient, és **trucar als serveis mèdics**. Posteriorment, començarem amb el **protocol** establert.

La **consciència** és sempre el primer signe vital que s'ha d'explorar.

Si respira

Hem de col·locar l'accidentat en PLS. En cas que el pacient respiri però tingui algun traumatisme, no s'ha de moure.

Si no respira

Col·locarem immediatament l'accidentat ajagut, mirant enlaire, en posició de decúbit supí. Posteriorment, procedirem a la hiperextensió del coll de l'accidentat desplaçant-li la mandíbula cap endavant i obrint-li la boca. Farem la respiració artificial, o boca a boca.

Si hi ha pols

Seguirem efectuant la respiració artificial.

Si no hi ha pols

Serà necessària la realització de la reanimació cardiopulmonar 30:2 (RCP).

[RCP](#) - Creu Roja

[RCP](#) - SEM

[RCP \(DEA\)](#) - SEM



Seqüència d'actuacions en el suport vital bàsic

PAS 1: Avaluació de l'entorn i primer contacte amb la víctima

- Realitzar una inspecció visual per **avaluar l'entorn**.
- **Contactar amb la víctima** preguntant-li: «Estàs bé?».
- Demanar ajuda especialitzada al 112.

**PAS 2:** Valoració primària

- Parlar al ferit,
- Observar si respira o sagna i
- Prendre el pols palpant la caròtida

Si la víctima
respon
(està conscient)

Cal mantenir-la en la mateixa posició,
si no hi ha altres perills.

S'ha d'esbrinar què li passa amb una
valoració secundària.

Si la víctima no
respon
(està inconscient)

Respira
i té pols

S'ha de col·locar
en posició lateral de
seguretat.

No respira
i té pols

S'ha d'aplicar la
reanimació respiratòria.

Ni respira
ni té pols

S'ha d'iniciar la rea-
nimació cardiopulmonar.

PAS 3: Valoració secundària

Exploració ràpida, ordenada i conscienciosa del ferit per cercar-hi lesions. Se li pregunta per les seves molèsties, per detectar problemes d'orientació o memòria.



Posició lateral de seguretat

1



S'ha de posar el braç més proper al socorrista en angle recte amb el cos i el colze doblegat amb el palmell de la mà cap amunt.

2



S'ha de portar el braç allunyat del socorrista creuant el tòrax i s'ha de recolzar el dors de la mà contra la galta del costat contrari de la víctima.

3



Amb l'altra mà, s'ha d'agafar la cama més allunyada just per sobre del genoll i s'ha d'aixecar, mantenint el peu recolzat a terra, i s'ha de girar el cos fins que quedi de costat.

4



S'ha de col·locar el dors de la mà del costat extern a sota de la galta.

[PLS](#) - SEM





Reanimació respiratòria (no obligatòria)

PAS 1: Preparació per a la respiració

- S'ha de col·locar la víctima en **decúbit supí sobre un pla dur**.
- Se li ha de girar el cap si **vomita**.
- Se li han de **treure, afluixar o estripar** les robes que li oprimeixin la gola, el tòrax o l'abdomen.
- Se li ha d'**inspeccionar la boca** i extreure'n qualsevol cos estrany (sempre que hi tinguem fàcil accés).



PAS 2: Obertura de les vies aèries

- S'ha de realitzar la **maniobra front-mentó** o la **tracció mandibular** per obrir les vies aèries.

PAS 3: Mirar, escoltar i sentir

- S'ha de **comprovar** que la respiració és normal (no més de 10 segons); si no, cal iniciar la reanimació:
 - Cal mirar si hi ha moviment toràcic.
 - Cal escoltar a prop de la boca de la víctima si hi ha sons respiratoris.
 - Cal sentir l'aire exhalat a la galta.



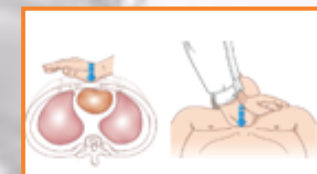
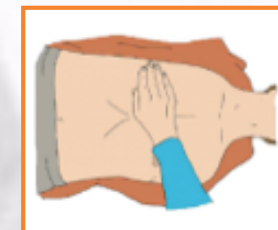
PAS 4: Respiracions de rescat

- Cal fer servir el **mètode boca a boca** o el **mètode boca-nas** (infants).
- Cal **pinçar el nas** amb els dits polze i índex de la mà que hi ha al front.
- Cal permetre que s'**obri la boca**, mantenint elevat el mentó.
- Cal fer una **respiració normal** i **segellar amb els llavis** la boca de la víctima.
- S'ha de **bufar dins de a boca** i **observar l'elevació del tòrax** (aprox. 1segon).
- Mantenint el cap estès i el mentó elevat, cal retirar la boca de la de la víctima i **observar el descens del tòrax mentre en va sortint l'aire**.
- Cal fer respiracions successives (de 12 a 15 vegades per minut) i s'ha de **parar** únicament si la víctima comença a respirar normalment.



Reanimació cardiopulmonar bàsica

- Cal col·locar la víctima en **decúbit supí** en una superfície llisa i ferma.
- Cal **agenollar-se al costat** de la víctima.
- Cal posar el **taló d'una mà al centre del tòrax** de la víctima.
- Cal posar el **taló de l'altra mà damunt de la primera entrelaçant els dits**.
- Cal col·locar-se verticalment damunt del tòrax amb els braços rectes i **pressionar sobre l'estern**, enfonsant-lo 5-6 cm.
- Cal repetir-ho amb una freqüència de **100 compressions / minut**.
- **Compressió i descompressió** = mateix temps
- Després de 30 compressions, s'ha de fer a **maniobra front-mentó (series de 30/2)**.
- Cal fer servir el **mètode boca a boca** o el **mètode boca-nas** (infants).
- Cal **pinçar el nas** amb els dits polze i índex de la mà que hi ha al front.
- Cal permetre que s'**obri la boca**, mantenint elevat el mentó.
- Cal fer una **respiració normal** i **segellar amb els llavis** la boca de la víctima.
- S'ha de **bufar dins de a boca** i **observar l'elevació del tòrax** (aprox. 1segon).
- Mantenint el cap estès i el mentó elevat, cal retirar la boca de la de la víctima i **observar el descens del tòrax mentre en va sortint l'aire**.
- Cal fer una altra respiració, fins a un total de **2 respiracions de rescat efectives (series de 30/2)**.
- Cal continuar **amb 30 compressions toràciques** per cada **2 respiracions de rescat (series de 30/2)**.
- S'ha de **parar** únicament si la víctima comença a respirar normalment, arriba l'ajuda o fins l'extenuació.
- Si no es pot o no es volen fer ventilacions **cal fer només compressions toràciques**.



Altres situacions en les que aplicar Primers Auxilis

Problemes cardiovasculars ([Creu Roja](#)):

Primers auxilis:

Cal traslladar l'afectat a un centre mèdic.

Ictus ([SEM](#)).

Problemes respiratoris ([Creu Roja](#)):

Primers auxilis:

Si respira: posar la persona semi asseguda, afloixar roba i objectes, proporcionar espai, obrir finestres, ajudar a administrar-se els medicaments que té prescrits, no donar menjar ni begudes.

Si no respira: iniciar reanimació cardiopulmonar.

Ennuegament ([SEM](#)):

Primers auxilis:

Ennuegament parcial: animar a tossir i vigilar.

Ennuegament total (no pot parlar, tossir ni respirar): 5 cops enèrgics interescapulars + maniobra de Heimlich.

Convulsions ([Creu Roja](#)):

Primers auxilis:

Evitar que es faci mal, no subjectar-lo, no obrir ni posar res a la boca i apuntar l'hora i durada de l'atac.



Altres situacions en les que aplicar Primers Auxilis

Lipotímia, desmai o hipoglucèmia:

Primers auxilis:

Aixecar les cames i airegeu l'ambient.

Si sospitem que es tracta d'una baixada de sucre (hipoglucèmia) i la víctima està conscient i col·labora podem donar beguda amb sucre.

([Lipotímies](#) - Creu Roja)

([Hipoglucèmia](#) - SEM)

Trastorns mediambientals:

Primers auxilis:

Cop de calor: treure roba, refrescar la víctima i portar a un lloc fresc ([Creu Roja](#) i [SEM](#)).

Hipotèrmia: portar a un lloc tancat, sec i calent, canviar la roba molla o humida per roba seca, aportar-li calor d'una manera gradual (bany aigua tèbia), mantenir en repòs i mai donar alcohol.

Congelació: actuar com en la hipotèrmia i no fer friccions a les extremitats congelades ni escalfar les zones congelades de segon (butllofes o negror) i tercer grau (lesions i esquerdes) per evitar dolor.

Intoxicacions ([Creu Roja](#)):

Mantenir via aèria oberta, esbrinar que ha ingerit, en cap cas s'ha d'induir el vòmit, si ho fa espontàniament lliurar-lo al servei mèdic amb els envasos buits.

Podéis encontrar los 12 videos en castellano de la [Guía de Primeros Auxilios de la Cruz Roja](#).



S'ha de fer amb la màxima cura, evitant agreujar les lesions existents o ocasionar-ne de noves.

Mètodes de trasllat:

Es sospiten lesions a la columna

Un socorrista i la víctima conscient, però sospitem que té fractura a la columna: es tractarà d'infondre-li tranquil·litat i de sol·licitar ajuda urgent.

Tècnica del pont: tres socorristes, amb l'accidentat estès entre les seves cames, l'aixequen al mateix temps, subjectant-li el cap, els malucs i les cames, com si fos un cos rígid, mentre un altre socorrista fa lliscar la llitera per sota del seu cos.

NO es sospiten lesions a la columna

Si es descarten lesions a la columna: el socorrista se situa darrere del cap de la víctima, es posa de genolls i passa els seus braços per sota de les axil·les del ferit per a traslladar a la víctima arrossegant-la.

La cadireta: la víctima està conscient, es descarten lesions a la columna i hi ha dos socorristes.

